Introducción a la Unidad 8

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 8: Evaluación del riesgo suicida. Elaborada por Dr Álvaro Jeria Durán, Médico Psiquiatra, Clínica Universidad de los Andes.

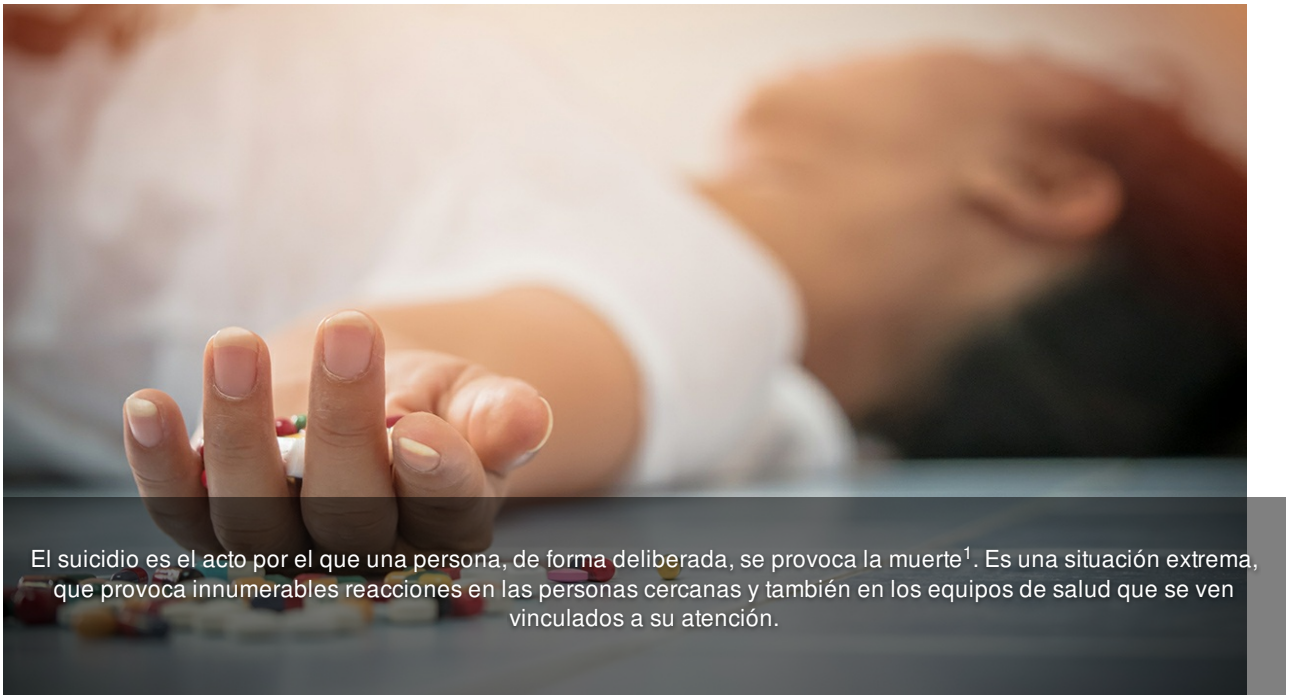
Objetivos de la Unidad

- Conocer la definición de suicidio, los factores de riesgo y factores protectores.
- Revisar la evaluación del riesgo suicida en el servicio de urgencia.

Temas de la unidad:

- El fenómeno suicida.
- Detección y manejo del riesgo suicida en el Servicio de Urgencias.

El fenómeno suicida



El suicidio es el acto por el que una persona, de forma deliberada, se provoca la muerte[1]. Es una situación extrema, que provoca innumerables reacciones en las personas cercanas y también en los equipos de salud que se ven vinculados a su atención.

La actual crisis derivada de la pandemia de Covid-19 se ha relacionado a un deterioro de la salud mental de la población, un aumento de la prevalencia de pensamientos suicidas, dificultades para acceder a servicios de salud mental, sumado a la evidencia de que epidemias anteriores (como el SARS en 2003) tuvieron un impacto significativo en aumentar las muertes por suicidio. Todo lo anterior se podría relacionar a un aumento de la mortalidad por suicidio, así como de las conductas suicidas en todo el mundo (John A, BMJ 2020).

Proveer adecuados cuidados de salud a pacientes con ideación o intentos suicidas en el contexto de un servicio de urgencias es una tarea desafiante, que va a requerir del compromiso de todo el equipo de salud.

Esto, aún más considerando el contexto que -en ocasiones- se presenta en los servicios de urgencia: intensa carga laboral, falta de camas de hospitalización y recursos, así como la dificultad inherente que representan estos pacientes, en que puede ser muy difícil determinar el verdadero alcance del riesgo suicida y de daño inminente (Betz et al, 2015). Sin embargo, es posible generar un cambio, considerando que las crisis suicidas son acotadas en el tiempo, y que se puede prevenir la conducta suicida repetitiva. Realizar una correcta evaluación del riesgo y determinar el mejor plan de manejo es esencial para lograr un adecuado impacto en la disminución de suicidios en nuestra población.

En la presente clase describiremos la realidad del suicidio en el mundo y en Chile, describiendo los factores de riesgo que pueden ayudarnos a detectar los casos más graves, y detallando una propuesta concreta de evaluación y manejo para el contexto de urgencias.

Definiciones

Entenderemos por suicidio:

> Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero móvil"[2].
>
> *Ministerio de Salud de Chile, 2013.*

En el complejo fenómeno de la conducta suicida, se pueden distinguir tres grupos de presentaciones, con características propias[3]:

Ideación suicida:

Se trata de aquellas personas que han pensado en la muerte, han tenido ideas de "no vivir o no estar", pero que no han llegado a una planificación suicida.

En la encuesta mundial de salud mental (EMSM), se encontró que un 3.4% de los adultos de la población general entrevistados había presentado ideación suicida en los últimos 12 meses. En Chile, una muestra representativa tuvo un 3.4% de ideación suicida en los últimos 12 meses[4].

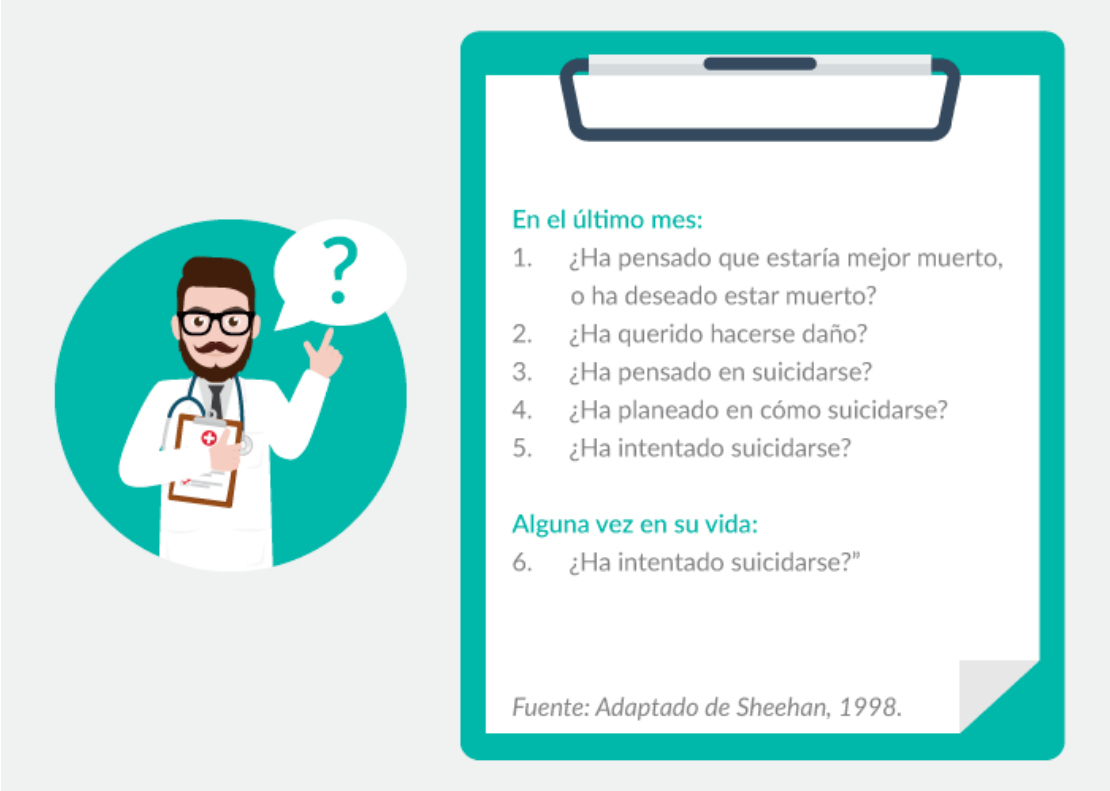
Planificación Suicida:

Se encuentran en este grupo aquellas personas que ya han planificado la forma en que se suicidarán. **La letalidad de dicho plan es un elemento clave como predictor del riesgo de fallecer por suicidio**. En la EMSM un 2.4% de las personas había tenido un plan en los últimos 12 meses (Borges et al, 2010); en Chile, llegaban al 2.4% (Gómez et al, 2018).

Intento Suicida:

En este grupo están todos aquellos que ya han presentado un intento suicida. Este grupo es altamente susceptible de llegar al servicio de urgencia. En la EMSM representan un 1.2% de las personas, que es concordante con lo encontrado en nuestro país por Gómez et al.

La forma más sencilla de indagar lo anterior es mediante preguntas directas, que busquen indagar la presencia de ideación suicida, como las que se utilizan en algunas entrevistas diagnósticas estructuradas, y se ejemplifican a continuación[5]:



Una respuesta positiva en las preguntas de la 1 a la 3 orienta la presencia de ideación suicida; la pregunta 4 entrega indicios sobre una planificación suicida, y la 5 y 6 sobre intentos suicidas, que aumentan dramáticamente el riesgo de fallecer por suicidio.

Realizar estas preguntas no tiene ningún impacto en el riesgo suicida per sé, con buena evidencia de que no se ve aumentado, y que por el contrario nos permite pesquisar casos de riesgo. Más adelante se planteará un esquema de acción frente a la detección del riesgo suicida.

El suicidio en el Mundo, y la situación en Chile

El suicidio ha sido ampliamente reconocido como un problema de salud pública a nivel mundial, causando alrededor de 804.000 muertes registradas en 2012, lo que equivale a que cada 40 segundos fallece una persona por suicidio en el mundo.

Datos actualizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018 muestran una tasa mundial de 10.6 suicidios por cada 100.000 habitantes, con rangos que van desde los 0.5 suicidios por 100.000 habitantes en Antigua y Barbuda (Antillas, Caribe), hasta la alta tasa que se encuentra en Lituania (Europa del Este) donde llega a 31.9 suicidios por cada 100.000 habitantes[6]. Esta cifra esconde además una diferencia entre hombres (con 15 suicidios por 100.000 habs) versus mujeres (que llegan a 8).

Se estima que las cifras que grafican el suicidio en el mundo están subdimensionadas, pues existe una profunda dificultad para registrar los actos suicidas, dada su condición de ilegalidad en muchos estados, con el consiguiente subreporte, a lo que se suman las diferencias en el mecanismo para determinar que una muerte es causada por suicidio.

En países con buenos sistemas de registro de defunciones, el dato del suicidio puede estar mal clasificado como muerte por accidente u otra causa. Dado que en muchos casos involucra a otras autoridades como las policías, en muchas oportunidades este dato sencillamente no se registra, o incluso se puede presumir omitido (como ocurre con las bajas cifras reportadas en China)[7].
Cada acto suicida además cobra una enorme relevancia cuando se considera que no solo se pierde una vida, sino que además se genera impacto en la familia, la comunidad, y finalmente la sociedad completa.

Y esto resulta aún más trágico cuando la evidencia científica disponible nos permite afirmar sin dudas que el suicidio es una conducta enteramente prevenible y evitable.

La situación actual relacionada a la pandemia de Covid-19 también ha generado un impacto negativo en la salud mental, y particularmente un aumento en las conductas suicidas (John A, 2020). Un estudio realizado en Estados Unidos mostró una clara asociación entre ideación suicida y experiencias negativas relacionadas a Covid-19 como aumento de la percepción de estrés general, temor de daño físico por la enfermedad, efectos de las cuarentenas y del distanciamiento social, entre otras (Amerman, 2021).

Revisiones de la evidencia acumulada sobre epidemias previas permiten reconocer que factores como la longitud del tiempo de aislamiento físico por cuarentena, el temor al contagio, así como el sexo femenino, factores socioeconómicos como pobreza y escasas redes de apoyo, se van a relacionar a un deterioro de la salud mental de la población, aumentando el riesgo de conductas suicidas (Brooks, 2020).

En Chile[8], el suicidio es un flagelo que ha cobrado cada vez más relevancia. La tasa de suicidio en Chile alcanzó los 12,36 suicidios por cada 100.000 habitantes el año 2008, disminuyendo progresivamente hasta los 9,32 suicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2014.

Esta disminución ha sido gradual y sostenida, lo que podría relacionarse con la mejora en la accesibilidad de atención de salud mental en la red pública de salud, así como una mayor conciencia de la población general sobre la posibilidad de brindar ayuda a las personas que presentan conductas o ideación suicida.

Probablemente el punto más preocupante es lo que ocurre con nuestros adolescentes, principalmente el grupo comprendido entre los 10 a 14 años.

En este grupo en particular se evidenció un aumento de 0,96 suicidios por cada 100.000 habitantes (año 2000) a 2,15 suicidios por cada 100.000 habitantes (año 2008), disminuyendo posteriormente a 1.71 suicidios por cada 100.000 habitantes en 2014. Del mismo modo, en el grupo de 15 a 19 años, la tasa de suicidio aumentó de 8,6 (2000) a 12,9 (2008), para descender hasta 8.17 suicidios por cada 100.000 habitantes por 100.000 habitantes en el año 2014[9].

Suicidio y consultas previas a servicios médicos

Se estima que entre un 5.7- 8% de los pacientes que consultan en un servicio de urgencias general presenta ideación o conductas suicidas, independientemente de su motivo de consulta; la mayoría de ellos no lo reportará, a menos que el equipo de salud le pregunte al respecto[10].

> Solo en el 25% de esos casos había algún registro en su ficha de atención de urgencias respecto a la presencia de ideación suicida".
>
> *Ronquillo et al., 2012.*

Varios estudios han mostrado que un gran número de pacientes que fallece por suicidio ha visitado a un médico durante el último mes[11]. Hasta el 82% de una muestra de personas que falleció por suicidio había consultado con un médico los 6 meses previos a su muerte. De ellos, 51% tenía un cuadro depresivo, pero solo el 38% había recibido el diagnóstico de depresión.

Esto significa que un porcentaje importante de estos pacientes podría consultar en el servicio de urgencias, sin notificar que padece una depresión ni que presenta ideas suicidas. (Ronquillo et al., 2012).

Una revisión de más de 40 trabajos ha demostrado que la mayoría de los pacientes que fallecen por suicidio ha visitado un servicio de salud primario el año previo a su suicidio, y un alarmante 20% de ellos ha tenido contacto con servicios de salud mental el mes previo a su muerte[12].

Más aún, 20% de los adultos que fallece por suicidio visitó a un médico en las 24 horas previas a su muerte[13].

Una medida de prevención del suicidio altamente costo-efectiva es que los profesionales de salud en general tengan por rutina preguntar a los usuarios sobre la presencia de ideas de muerte o de suicidio en todas las consultas de rutina.

> Esto ha demostrado que no aumenta el riesgo de muerte por suicidio, sino que por el contrario puede abrir una ventana de búsqueda de ayuda para la persona aquejada por ideas relacionadas al suicidio".
>
> *Luoama et al, 2002.*

Considerando todo lo anterior, es fundamental que el equipo de salud de urgencias este sensibilizado y capacitado respecto al fenómeno del suicidio en su población consultante, y que cuente con estrategias claras para su detección y manejo.

Riesgo suicida: ¿Qué factores de riesgo se han podido identificar para el Suicidio?

El suicidio es un fenómeno causado por diferentes factores que interactúan entre sí, de modos íntimos y complejos. Esto, pues no debemos olvidar que a la base del fenómeno suicida se encuentra uno de los fenómenos más complejos para la medicina, que aún lo considera un desafío pendiente: la conducta y la voluntad humana.

Pese a ello, y a que debemos considerarlo como un fenómeno multifactorial, existe amplia evidencia sobre algunos de los factores de riesgo que pueden iluminar el camino hacia estrategias efectivas para la prevención del suicidio, y que pueden iluminar la entrevista a realizar en el servicio de urgencia con el paciente que presenta ideas de muerte.

Quizás la información más clara que tenemos en este punto es que **nunca un suicidio es enteramente explicable por un solo factor de riesg**o o estresor.

Poder entonces conocer la población a proteger, así como sus circunstancias y ubicación geográfica, permite considerar los factores de riesgo para la conducta suicida. Esto es esencial al momento de poder diseñar políticas, planes y programas orientados a su prevención, que además tengan en cuenta el severo estigma y la discriminación que las personas sufren en relación al suicidio.

El proceso que el equipo de urgencias debe realizar con estos pacientes no es diferente del que se realiza para evaluar otras patologías (Ronquillo et al, 2012), por ejemplo, lo que ocurre con la evaluación de un infarto agudo al miocardio (IAM). La historia familiar de IAM precoz hará que el paciente tenga un mayor riesgo de IAM, pero esa historia es irrelevante si el paciente está presentando un IAM en el momento presente.

En el caso del suicidio esto es similar, considerando que los dos elementos de riesgo más claros son: la historia previa de intentos suicidas, y la presencia de ideación suicida activa actualmente, especialmente si el plan es de alta letalidad.

Algunos factores de riesgo a considerar son[14]:

Suicidio y enfermedad mental

Extensa evidencia científica apoya el hecho de que uno de los principales factores de riesgo para el suicidio es que la persona esté padeciendo una enfermedad mental, patologías que hoy son tratables, en la gran mayoría de los casos con buenos resultados para la persona y su familia.

La depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, y la adicción a drogas y alcohol son las patologías más relevantes al momento de analizar el aumento de la suicidalidad, pudiendo aumentar hasta en 10 veces el riesgo de suicidio.

Mediante autopsias psicológicas se ha podido llegar a determinar que hasta un 90% de las personas que fallece por suicidio estaba padeciendo de una enfermedad mental, siendo la principal de ellas (casi la mitad) depresión.

La presencia de dichas enfermedades, muchas veces con dificultad en el diagnóstico y el acceso a un adecuado tratamiento es, entonces, una de las principales oportunidades para introducir mecanismos de prevención del suicidio a un sistema sanitario: mejorar la sospecha, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales tiene un impacto positivo en disminuir las tasas de suicidio a nivel mundial.

Suicidio y antecedentes personales y familiares

Múltiples factores familiares y personales (sociales, psicológicos y culturales) interactúan con el suicidio, confiriendo mayor riesgo a jóvenes y adultos mayores. Existiría una carga genética asociada, principalmente relacionada a la disponibilidad cerebral de serotonina y noradrenalina, que son los neurotransmisores que intervienen en el ánimo, angustia y motivación.

Las experiencias traumáticas en la infancia, y dentro de ellas la violencia y particularmente el abuso sexual, tendrían una clara asociación con el mayor riesgo de fallecer por suicidio.

Así también los eventos vitales estresantes, dentro de los que destaca:

La muerte de la pareja o de un familiar significativo, el quiebre de relaciones sentimentales relevantes, la presencia de enfermedades físicas graves (principalmente las que cursan con dolor crónico), o cualquier otro evento que genere estrés psicológico puede relacionarse a este fenómeno.

La existencia de intentos previos de suicidio en la historia vital de una persona se relaciona a un mayor riesgo de fallecer por suicidio, sobre todo los 12 meses que siguen a dicho evento, llegando a ser el factor de riesgo de suicidio más importante en la población general.

Se estima que por cada adulto que se suicidó, habría al menos 20 otros que intentaron suicidarse.

Por otra parte, las personas que requieren de una hospitalización en unidades de salud mental tendrán un mayor riesgo las dos semanas siguientes al alta de estos dispositivos.

Las personas que tienen antecedentes familiares de suicidio tienen un riesgo cuatro veces mayor de fallecer por suicidio, al compararlos con personas que no tiene dicho antecedente.

Detectar de modo activo a las personas que han cursado con ideación suicida o que han tenido intentos de suicidio constituye, entonces, una manera adecuada y efectiva de prevención del suicidio. Debe ser un objetivo de cualquier programa el **visibilizar dichos casos, y poder proveer de alguna solución de seguimiento en el tiempo para ellos.**

Suicidio y determinantes sociales

Existe también abundante evidencia sobre el impacto que tienen diversos factores sobre el aumento del suicidio.

La pobreza, la inequidad social, la falta de acceso a salud y educación, el origen étnico, el desempleo, se cuentan entre estos factores.

Acceso a medios letales

El acceso y disponibilidad de medios letales para atentar contra la propia vida es uno de los temas más estudiados en la literatura científica en relación al riesgo de fallecer por suicidio. La posibilidad de acceder a un método letal condiciona muchas veces que una idea suicida pueda transformarse en un acto.

Los hombres en general eligen métodos más violentos (ahorcamiento, o armas de fuego, que dan cuenta de un 55% de los suicidios de varones), mientras que la población femenina tiende a la utilización de métodos menos violentos, como las intoxicaciones medicamentosas[15].

También existen métodos que son propios de ciertas localidades, como puentes o rocas en altura, donde una restricción de acceso logra tener un enorme impacto en la disminución del suicidio.

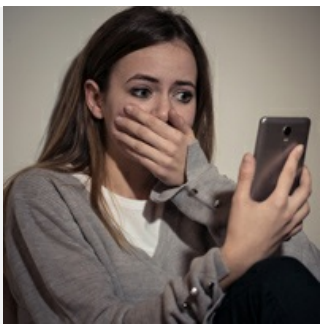
La disponibilidad de estos métodos varía según las zonas geográficas. Así, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica el principal método es por arma de fuego, sobre todo en hogares que cuentan con dichas armas. En muchas áreas rurales de países en vías de desarrollo, la ingesta de pesticidas es el método más utilizado por su toxicidad, fácil acceso y escasas medidas de control de su almacenamiento. Se estima que hasta un 30% de las muertes por suicidio a nivel mundial corresponden a intoxicaciones por pesticidas[16].

Cultura, tecnología y grupos de pertenencia

Uno de los factores de riesgo para suicidio se ha desprendido de los veloces cambios que nuestra sociedad ha experimentado en relación a las comunicaciones interpersonales, y la irrupción de las redes sociales como un nuevo paradigma de comunicación, especialmente entre los jóvenes.

Es ampliamente conocido el efecto de aumento del suicidio cuando un par fallece por suicidio. Las personas cursando un duelo por la pérdida de un ser querido tienen mayor riesgo de fallecer por suicidio, pero esto también ocurre en los grupos de pares, especialmente en escuelas, colegios, y comunidades de adolescentes.

Además, a este fenómeno se suma hoy el acceso a mayor información, sin gran regulación por parte de los adultos responsables de los jóvenes, lo que puede gatillar “clusters o enjambres” suicidales.



El abordaje en los medios de comunicación también ha mostrado contribuir a dicho efecto, sobre todo si el reporte es sensacionalista, si incluye titulares dramáticos o incluye fotografías, si reporta en detalle el método suicida, o si se trata de un personaje público o “famoso”. Existe escasa evidencia sobre el efecto de la circulación de videos, fotografías o notas suicidas en redes sociales, pero del punto de vista clínico es posible desde ya considerarlo como un nuevo factor de riesgo suicida, principalmente en jóvenes.

Suicidio en tiempos de Coronavirus

Un nuevo factor a considerar es el impacto que la pandemia de Covid-19 está teniendo sobre la salud mental de la población, y directamente sobre el riesgo de suicidio. Si bien la mayor parte de los estudios aún son preliminares, contamos ya con evidencia que permite afirmar que hay una mayor carga de patologías relacionadas a la salud mental, de una manera bidireccional: los pacientes afectados previamente por Covid-19 tienen un riesgo aumentado de presentar secuelas psiquiátricas (donde lo más significativo es depresión, ansiedad e ideación suicida); y los pacientes aquejados de enfermedades psiquiátricas crónicas tienen un mayor riesgo de contraer Covid-19[17].

En este mismo sentido, los trabajadores de la salud también van a tener un riesgo aumentado de suicidio y enfermedad mental en esta situación de pandemia. Esto se relaciona a mayor carga laboral, más incertidumbre respecto de las condiciones de sus trabajos, exposición a contagio y falta de Elementos de Protección Personal, poco espacio de descanso, temor a contagiar a su familia, y preocupación por el bienestar económico y material a futuro, así como estigma y discriminación hacia los trabajadores de la salud en el ámbito social[18].

Cabe destacar que los principales grupos de riesgo serán mujeres jóvenes, con hijos, con menor nivel educacional y con historia previa de enfermedades psiquiátricas. Sin duda que este es un desafío en evolución, pero mantener alerta respecto a las consecuencias neuropsiquiátricas del Covid-19 y su efecto sobre la suicidalida es algo que debe ser evaluado adecuadamente.

Los factores de riesgo suicida se pueden categorizar entre factores **crónicos y agudos**. En la siguiente tabla se detallan, destacando en negrita aquellos factores que son modificables en una consulta de urgencias.

Tabla: Factores de Riesgo de Suicidio	
Crónicos	Agudos
Intentos previos	Ideación suicida
Hospitalización reciente	Apropositividad vital
Vivir solo	**Insomnio**
Historia familiar de suicidio	**Ansiedad, angustia, agitación**
Pertenecer a la comunidad LGBTQI	Sensación de estar atrapado
Eventos vitales adversos en la infancia	Mala adherencia a cuidados profesionales
Eventos vitales estresantes	Duelo
Enfermedades psiquiátricas	Rabia, Ira, deseos de venganza
Enfermedad física	Conducta imprudente o temeraria
Desempleo	Cambios de ánimo o personalidad
Edad avanzada	**Uso de sustancias**
	Desesperanza

Fuente: Adaptado de Weber 2017.

También se han identificado los llamados Factores Protectores frente al riesgo suicida. (Weber, 2017). Todos los pacientes cuentan con estos factores, a los que se puede echar mano en momentos de crisis suicida. Se sugiere evaluar en general con preguntas como:

En la siguiente tabla se resumen los factores protectores, divididos en modificables y no modificables.

Tabla: Factores Protectores del Riesgo de Suicidio	
No Modificables	Modificables
Género femenino	Apoyo interpersonal
Matrimonio	Habilidades personales frente a la crisis
Hijos	Satisfacción con la propia vida
Embarazo	
Religión/espiritualidad	

Cada uno de estos factores modifica el riesgo de fallecer por suicidio de una manera dinámica.

Como plantea Weber, por ejemplo el matrimonio puede ser una fuente de apoyo, pero también podría ser un factor de mayor riesgo cuando la persona enfrenta violencia intrafamiliar.

Los hijos son un factor demostrado de protección, a excepción por el caso de mujeres con depresión o psicosis postparto, embarazo adolescente o no deseado, y severas dificultades económicas.

Pese a ello el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte materna, en países desarrollados, por lo que la salud mental perinatal de la madre debe ser siempre un foco de atención para el equipo de salud.

autopsias psicológicas: Se define como el método de investigar retrospectivamente las características de la personalidad y las condiciones que en vida tuvo un individuo, teniendo como objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias de su muerte. (Litman, 1989).
LGBTQI: Comunidades y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, queer e intersex..

Detección y manejo del riesgo suicida en el Servicio de Urgencias

El principal objetivo de la evaluación del riesgo suicida es determinar si existe un riesgo inminente al momento de evaluar al paciente, y determinar cuál es la mejor conducta a implementar para dicho paciente[1].

Es altamente deseable que cada servicio de urgencia pueda contar con un protocolo específico para el manejo del riesgo suicida, que sea adecuado a la carga laboral y a la cultura de cada servicio, y que sea ampliamente difundido entre el equipo de salud.

No existe un consenso definitivo sobre a qué pacientes se debe interrogar dirigidamente sobre su riesgo suicida. (Weber et al, 2017).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todos los pacientes de más de 10 años de edad con alguna patología psiquiátrica, epilepsia, conflictos interpersonales, eventos vitales estresantes recientes, u otro factor de riesgo para suicidio, debe ser evaluado acerca de ideas o planes de autoagresión o suicidio.

La Joint Comission norteamericana recomienda que todos los pacientes que consulten por síntomas emocionales o conductuales deben ser evaluados sobre este riesgo.

En una revisión reciente, la United States Protective Task Force (USPTF) considera que la evidencia para recomendar screening en población general de suicidio es insuficiente, considerando que se debe evaluar en pacientes con enfermedades psiquiátricas, estrés emocional, o historia previa de intentos suicidas. (Weber et al, 2017).

> Al momento de realizar la evaluación del riesgo suicida no debemos perder de vista que se trata de pacientes que están una crisis emocional aguda, y que al igual que pacientes que se presentan al servicio de urgencias con dolor físico, acá el dolor emocional merece recibir una atención de salud adecuada, empática y centrada en el paciente".
>
> *Betz et al, 2015.*

Mejorar la experiencia del paciente puede ser muy sencillo, como explicar qué evaluación se va a realizar y tratar de proveer las mejores condiciones ambientales que sea posible.

No es raro que entre quienes nos desempeñamos en salud se instalen prejuicios, estigma e incluso discriminación hacia los pacientes que consultan por ideación o intentos de suicidio. Muchos profesionales de salud pueden “ser escépticos de la preventibilidad del suicidio, o pueden tener sesgos hacia los pacientes con enfermedades psiquiátricas, así que este es un desafío para que estos profesionales superen sus propias áreas de discomfort” con estos pacientes (Betz et al, 2015).

Tratar de establecer una relación cordial pero directa, considerando además que un alto porcentaje de estos pacientes padece de una enfermedad psiquiátrica a la base, es importante.

Del mismo modo, no olvidar que el indagar sobre la ocurrencia de ideación suicida, presencia de planificación o de intentos suicidas previos NO aumenta en ninguna forma el riesgo de presentar conductas suicidas.

Se deben realizar las preguntas específicas necesarias para evaluar el riesgo. Recopilar información sobre terceros será esencial al momento de diseñar el plan de acción según el riesgo detectado.

Algunas fuentes relevantes de información son: familiares, acompañantes o amigos del paciente; ficha electrónica; otros profesionales o dispositivos que hayan dado tratamiento al paciente.

En la medida de lo posible se sugiere indagar las redes más relevantes, principalmente familiares y equipo tratante en caso de que exista uno.

Durante la evaluación es fundamental velar por la seguridad del paciente. NO se debe permitir que el paciente abandone el servicio de urgencias hasta que la evaluación se haya completado, y durante todo el tiempo que se requiera se debe minimizar el riesgo de autoagresiones al interior del servicio de urgencias.

Lo ideal sería contar con una habitación o box individual, sin acceso a elementos potencialmente peligrosos (como equipo médico, pero también cinturones, cordones o lazos, objetos cortopunzantes, etc.).

Se deben aplicar las medidas descritas en la Unidad 7 en caso que el paciente se presente con agitación psicomotora. Debe intentarse, de manera simultánea a la evaluación, lograr realizar algo de contención verbal que permita mantener al paciente colaborador, al mismo tiempo que nos permite evaluar el estado de conciencia.

Se debe considerar, del mismo modo que se aborda en la Unidad 7, una adecuada evaluación médica orgánica, descartando patologías médicas no-psiquiátricas que puedan estar causando la sintomatología.

Se sugiere siempre realizar un chequeo de exámenes generales (como un “point of care”), así como exámenes toxicológicos y de niveles de posibles sustancias ingeridas por el paciente (como paracetamol).

Evaluar el estado de conciencia va de la mano de conocer el estado emocional del paciente, y abordar posible ingestión de tóxicos o drogas, trauma, lesiones, etc. (Se sugiere revisar Unidad 7 para mayor profundidad sobre esto).

Algunas características específicas de los pacientes a evaluar pueden orientar a pesquisar el riesgo suicida, a saber:

- Cambios en el ánimo (síntomas depresivos, estrés emocional, rabia, irritabilidad, agresión).
- Ansiedad o agitación.
- Quejas sobre el sueño.
- Evidencia de conducta impulsiva.
- Cambios repentinos en las circunstancias de vida de la persona (viudez, pérdida de su fuente laboral).
- Aumento del uso de alcohol o drogas.
- Mala adherencia a su tratamiento (fármacos, psicoterapia).
- Consulta por sugerencia/presión de familia o amigos (más del 50% de los pacientes que consulta antes del suicidio lo hace por presión de terceros).

Es clara la evidencia de que cuando se interroga a los pacientes sobre pensamientos o conductas suicidas, no se produce un aumento de la suicidalidad, independientemente de la edad, presencia de depresión, o historia previa de conductas suicidas del paciente (Weber et al, 2017).

El set básico de preguntas a utilizar es el planteado por Sheehan en 1998, detallado previamente en esta clase.

Poder tener claridad sobre el riesgo nos permitirá definir la conducta a seguir, que va desde el alta con supervisión por terceros, hasta la hospitalización y derivación a una unidad de hospitalización psiquiátrica, cuando dicho recursos se encuentre disponible, e incluyendo la hospitalización contra la voluntad del paciente en casos que la ideación y planificación suicida sean inminentes.

Identificar correctamente qué pacientes son susceptibles de ser enviados a su domicilio bajo la supervisión de terceros es una habilidad que el equipo de salud debe entrenar.

Se debe considerar en este grupo a pacientes que NO presentan ideación suicida activa planificada al momento de la evaluación, que podrían haber tenido ideas de muerte, e idealmente que no cuenta con factores de riesgo para

suicidio.

Al igual que la evaluación de urgencias de un dolor abdominal, esto requiere práctica y revisión en sucesivas oportunidades de la información expuesta en esta unidad.

Si existen entonces las condiciones necesarias, y el equipo de salud indaga sobre las preguntas iniciales (Sheehan 1998), siendo las respuestas negativas y confiables; en un paciente con claridad de conciencia, sin historia de intentos suicidas previos, sin historia de enfermedades psiquiátricas, sin abuso de sustancias, sin agitación ni irritabilidad, este paciente se puede referir a manejo ambulatorio sin consulta previa con el especialista, siempre y cuando exista un adulto responsable dispuesto a asumir el cuidado del paciente las 24 horas, de manera presencial, hasta que haya sido evaluado en la unidad disponible para ello.

Al igual que el médico de urgencias logra hacer un buen triage del dolor abdominal tras una correcta evaluación, el equipo de salud debe tener el mismo objetivo con el riesgo suicida.

Betz plantea como ejemplo *una mujer de edad media, con síntomas depresivos, ideas vagas de muerte sin planificación, que efectivamente cuenta con una buena red de apoyo, y que dice que nunca se haría daño porque su religión se lo impide, puede ser candidata a ser derivada a su domicilio* (Betz 2016).

En nuestro país podemos obtener información sobre las redes disponibles en cada servicio de salud a través de **Salud Responde** (como comentamos en el video más adelante). Es importante que el equipo de salud conozca las redes disponibles para la correcta derivación de los pacientes atendidos por este motivo en el servicio de urgencias, y que en nuestro país difieren mucho de territorio en territorio.

Otro recurso que vale la pena conocer es el **"Suicide Prevention Resource Center"** que depende del ministerio de salud de EEUU, ha publicado variados documentos respecto al protocolo de evaluación y prevención sobre el suicidio.

Se sugiere visitar:

Hipervínculo externo: *Suicide Prevention Resource Center* VER

En 2015 diseñaron y publicaron una guía de manejo del riesgo suicida en servicios de urgencias, que se sugiere revisar para mayor profundidad. Ahí proponen un set acotado de preguntas tipo a considerar, que se debiese incluir[2]:

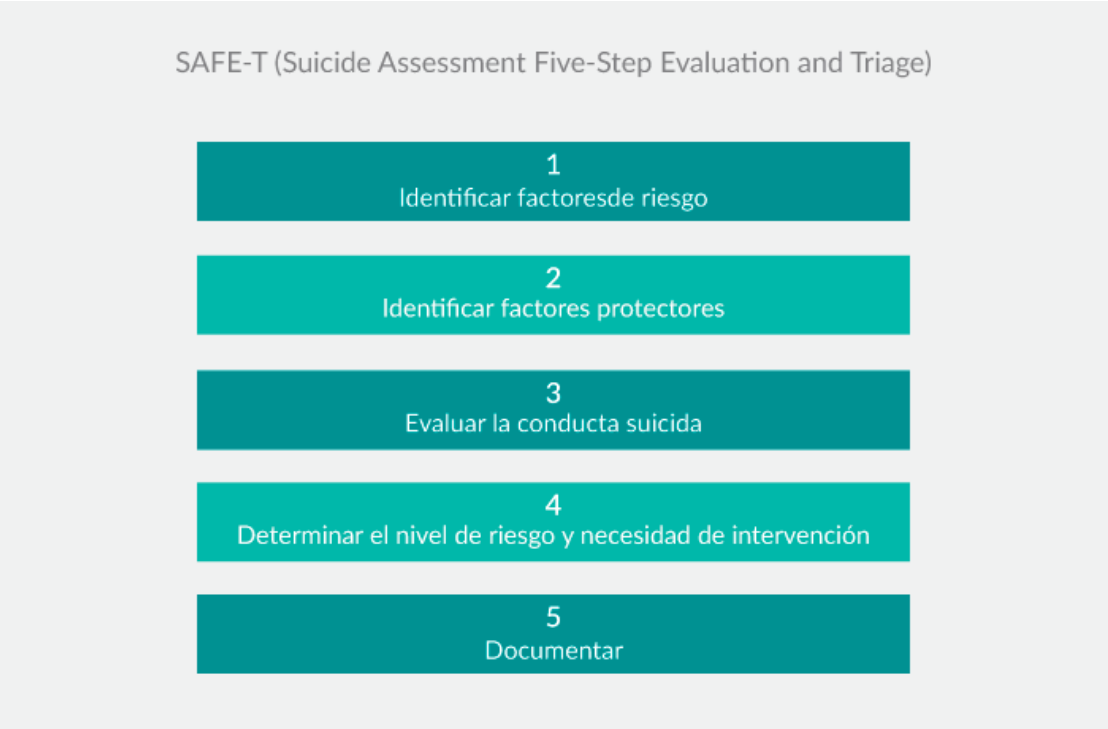
Para ello es imprescindible que el paciente colabore: pacientes somnolientos o intoxicados con sustancias deberán entonces ser monitorizados en unidades adecuadas para ello, hasta haber descartado complicaciones médicas y que su estado de conciencia permita llevar adelante una evaluación adecuada.

Cabe mencionar que los pacientes que durante una intoxicación (por ejemplo con alcohol) manifiestan ideas de muerte, y que las niegan al recobrar la sobriedad, deben ser evaluados exhaustivamente, sobre todo considerando la asociación entre el suicidio y el consumo de sustancias: más de ⅓ de las personas que fallecen por suicidio habían consumido alcohol antes de su muerte.

Una evaluación más exhaustiva del riesgo suicida debiese en lo ideal ser realizada por un especialista, tanto psiquiatras como psicólogos adecuadamente entrenados. Si cuenta con el recurso, debe realizar la interconsulta a especialidad. Habitualmente el especialista (como en cualquier otra consulta de especialidad) contará con mayor experiencia y tiempo para la evaluación del paciente.

Esto no excluye el hecho de que el equipo responsable del paciente es el equipo de urgencias, y el interconsultor entrega elementos que deberán ser tomados en consideración para la decisión sobre la mejor derivación del paciente. Esta consulta, en muchos casos, puede ser a distancia.

En el caso que no sea posible contar con una interconsulta adecuada, existe una evaluación en 5 pasos que sistematiza la evaluación del paciente con riesgo suicida en la urgencia, llamada SAFE-T (Suicide Assessment Five-Step Evaluation and Triage).



En el siguiente link se encuentra disponible a modo de tarjeta de resumen de los 5 pasos básicos de la evaluación.

Hipervínculo externo: *SAFE-T* VER

Determinación del riesgo

El objetivo de todo lo descrito anteriormente es que el equipo de salud de la urgencia sea capaz de discriminar el nivel de riesgo de fallecer por suicidio del paciente, y que en relación a ello se puedan tomar las medidas necesarias. Weber propone una modificación al paso 4 de la SAFE-T, que permite resumir en una tabla lo evaluado para determinar el nivel de riesgo (categorizado en leve, moderado y severo), y las “respuestas recomendadas” (Ver tabla).

Tabla: Determinación del Nivel de Riesgo y Respuesta Recomendada			
Nivel de Riesgo Agudo	Característica del Nivel		
	Factor de Protección	Factor de Riesgo Agudo	Evaluación Suicidalidad
Leve	Fácilmente identificable, muchos factores protectores.	Pocos factores de riesgo, síntomas anímicos leves, evidencia de buen auto-control.	Ideación suicida limitada en frecuencia, intensidad o duración. Sin plan ni intentos previos.
Moderado	Algunos factores protectores identificables.	Factores de riesgo crónicos, síntomas anímicos leves, mantiene auto-control. Escasos factores de riesgo agudo.	Ideación suicida frecuente, pero limitada en intensidad o duración. Podría haber planificación, pero sin intentos previos.
Severo	Mínimos factores protectores.	Muchos factores de riesgo agudo, escaso auto-control. Consumo de sustancias.	Ideación suicida frecuente, intensa y persistente, planificada.

Las respuestas recomendadas por nivel de riesgo propuestas por Weber et al. son:

Riesgo Leve

1.- Control ambulatorio frecuente, para determinar cambios en el riesgo.
2.- Evaluación de síntomas anímicos.
3.- Considerar derivar a un psiquiatra.

Riesgo moderado

1.- Aumentar frecuencia/duración de las consultas. Evaluar de manera repetida para determinar necesidad de hospitalización.
2.- Incluir a la familia y red de apoyo.
3.- Restringir el acceso a métodos letales: restringir el acceso a armas de fuego, alcohol/drogas, u otros métodos de autoagresión ha demostrado disminuir el riesgo de suicidio.
4.- Revisar protocolos de emergencia: dónde y a quién acudir en caso de necesidad.
5.- Tratar síntomas anímicos con fármacos y/o psicoterapia.
6.- Control ambulatorio frecuente, visita domiciliaria (disponible en APS).
7.- Considerar derivación a psiquiatra u hospitalización, especialmente si el riesgo se incrementa en las evaluaciones sucesivas.

Riesgo Severo

1.- Evaluación para hospitalización psiquiátrica, por psiquiatra idealmente, o referir a servicio de urgencia que cuente con el recurso.
2.- No dejar al paciente solo en ningún momento.
3.- Hospitalización puede indicarse, incluso cuando sea en contra de la voluntad del paciente.
4.- Restringir el acceso a métodos letales, durante la hospitalización y al menos 2 semanas después del alta.

Cabe destacar que en Chile las hospitalizaciones psiquiátricas involuntarias están reguladas por el Decreto Supremo 20.584, que está actualmente en revisión, y que permite la hospitalización psiquiátrica involuntaria cuando el paciente se encuentre en una situación de riesgo vital para sí o para terceros.

Esta hospitalización se realiza a través de un trámite administrativo que debe incluir a un psiquiatra que la indica, y a familiares del paciente que apoyen y realicen dicha gestión ante la SEREMI de Salud de cada Región, según corresponda.

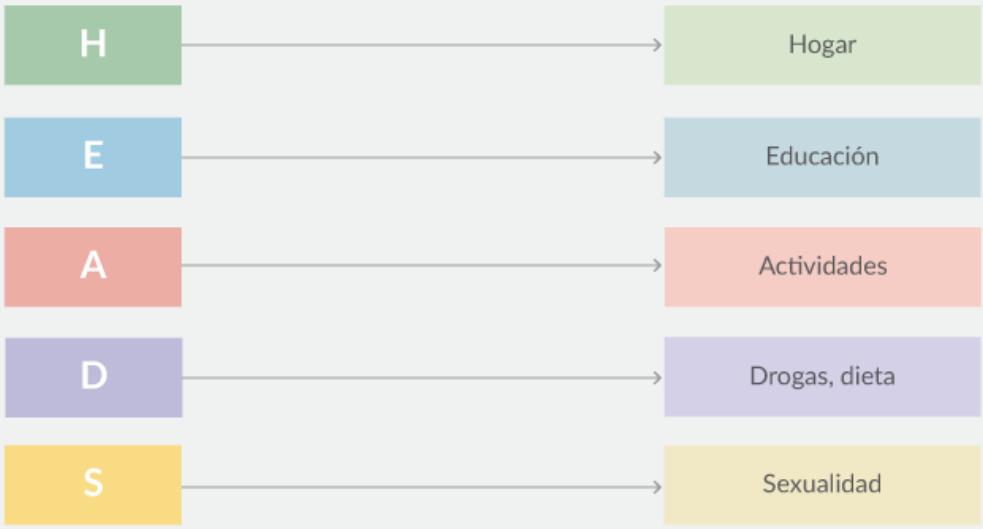
Se trata de casos excepcionales, pero que, considerando que en los trastornos del ánimo y el consumo de sustancias muchas veces se encuentra la base de la ideación suicida, puede permitir salvar la vida del paciente mediante el acceso a un tratamiento adecuado de su patología.

Evaluación en poblaciones especiales: Adolescentes

En adolescentes, se ha recomendado el uso de una evaluación llamada HEADS por su acrónimo en inglés (ver figura 1).

El foco principal de la entrevista con el adolescente será entender la sintomatología que presenta a la luz de su desarrollo, pero a la vez empoderarlo sobre su autocuidado.

Figura 1: acrónimo de evaluación HEADS (De OPS, 2000)



Fuente: OPS, 2000.

El setting de urgencias puede contribuir de manera poderosa a la salud adolescente, grupo en el que previamente discutíamos sobre el gran riesgo que representa el suicidio.

Para abordar dicha entrevista de manera integral, se puede lograr (en pocos minutos, ajustado al setting de urgencias) con una breve lista de preguntas:

Preguntas tipo para evaluación HEADS[3]

Hogar

- ¿Cómo están las cosas en casa, con tus padres, tus hermanos?
- ¿Estás viviendo con tus dos padres en casa?

Educación

- ¿Cómo te está yendo en la escuela o el liceo? ¿Te gusta la escuela?
- ¿Te va mejor o peor que tus compañeros? ¿Qué haces al salir de la escuela?

Actividades

- ¿Qué otras cosas haces además de la escuela?
- ¿Tienes muchos amigos con quienes sales?
- ¿Qué te gusta hacer?

Drogas, Dietas

- ¿Hay un problema de drogas en tu escuela?
- ¿Qué piensas de usar drogas, qué hacen tú y tus amigos con respecto a las drogas?
- ¿Te parece un problema?
- ¿Te preocupa tu peso y tu cuerpo?
- ¿Has estado haciendo dietas últimamente?

Sexualidad

- ¿Tienes un novio/a o alguien con quien sales más?
- ¿Cómo son tus relaciones con esa pareja?
- ¿Qué piensas sobre tener relaciones sexuales?

Otras medidas para el manejo del riesgo suicida

Como hemos detallado en esta unidad, el riesgo suicida se relaciona fuertemente con la presencia de patologías psiquiátricas, principalmente depresión, y consumo de sustancias.

En ese sentido, el correcto tratamiento de las patologías del ánimo tiene un claro impacto en disminuir el riesgo suicida. Una derivación oportuna a psiquiatra, así como el uso correcto de medicamentos como antidepresivos y ansiolíticos disminuye el riesgo suicida, por otra parte, el uso de hipnóticos o sedantes, especialmente en mayores de 65 años, puede multiplicar por 4 el riesgo suicida (Weber et al, 2016).

La psicoterapia ha demostrado disminuir los intentos suicidas en más de un 30%, principalmente en Terapia Cognitivo-Conductual, Terapia Conductual Dialéctica (o DBT), principalmente impactando en la disminución de conductas autolesivas e ideación suicida.

Medidas sencillas como el envío de un correo (físico o electrónico) de seguimiento algunos días después de la consulta de urgencias, visitas domiciliarias (disponibles en Chile en la Atención Primaria de Salud), u otras formas de seguimiento también tendrían un impacto en el riesgo suicida.

El acceso a líneas telefónicas de apoyo (como Salud Responde en Chile) ha demostrado ser útil, sobre todo cuando tienen algoritmos y protocolos de respuesta.

Es importante, por último documentar adecuadamente lo realizado, tanto en la ficha clínica como en la información que se entregue al paciente y sus acompañantes. Trazar un plan de cuidados (o “Plan de Seguridad”), idealmente por escrito, que considere signos de alarma para una nueva consulta, sugerencias de manejo en el domicilio, y lineamientos sobre la derivación sugerida, son de extrema utilidad, pues han demostrado reducir los intentos suicidas, síntomas depresivos y desesperanza en los 3 meses siguientes a la evaluación, al compararlo con manejo sin Plan de Seguridad.

Existen ejemplos de estos planes en diversos sitios y aplicaciones:

Hipervínculo externo: *Patient Safety Plan Template* VER

Puntos Principales

- La evaluación del riesgo suicida es un desafío para los equipos de salud, especialmente en los servicios de urgencias. Es diferente a la evaluación de otras emergencias médicas, pues debe considerar múltiples factores que interactúan de manera particular en cada caso, sin algoritmos únicos ni respuestas adecuadas para todos los pacientes, y considerando el enorme impacto que situaciones como la actual pandemia de Covid-19 impone sobre la salud mental y, por ende, el riesgo suicida.
- La presencia de patologías psiquiátricas como depresión y consumo de sustancias se relaciona a un mayor riesgo de fallecer por suicidio, así como otros factores de riesgo y protectores.
- La evaluación del riesgo suicida exige al equipo de salud que evalúa al paciente contar con el conocimiento base y la experiencia clínica para poder categorizar el riesgo y tomar las mejores conductas para cada caso particular.
- Finalmente, una de las intervenciones que mayor impacto tiene en mejorar la resolutividad de las unidades de urgencia sobre los pacientes suicidas es, precisamente, la capacitación del equipo de salud. ¡Es precisamente lo que hemos estado realizando en conjunto a lo largo de esta Unidad!
- Volver a visitar los contenidos de esta unidad, y poder revisar el material sugerido les ayudará en concreto a tener una mejor detección y manejo del riesgo suicida, sin olvidar nunca que se trata de un ser humano que sufre, que necesita de nuestra atención, y que con el manejo correcto podrá salir de la crisis que enfrenta y seguir adelante con su vida.

Video Evaluación y derivación oportuna

Vea este video en la versión online de la clase

Video Canales de derivación

Vea este video en la versión online de la clase

Bibliografía Unidad 8

- Betz ME, Boudreaux ED. Managing Suicidal Patients in the Emergency Department. Ann Emerg Med. 2015;67(2):276–282
- Borges G, et al. Twelve-month prevalence of and risk factors for suicide attempts in the World Health Organization World Mental Health Surveys. J Clin Psychiatry. 2010 Dec;71(12):1617-28.
- Caring for Adult Patients with Suicide Risk: A Consensus Guide for Emergency Departments. SPRC, 2015
- Gómez A, et al. Acceso diferencial a tratamiento de salud mental en sujetos con intento de suicidio y suicidio consumado. Un estudio de casos y controles en la red asistencia. Presentación sobre proyecto FONIS SM 14I006.
- Hawton K, van Heeringen K. Suicide. Lancet 2009; 373: 1372–81
- Litman R. 500 Psychological Autopsies. Journal of Forensic Sciences, 1989; 34 (3): 638-646.
- Luoma JB, et al. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry. 2002 Jun;159(6):909-16.
- Pirkis JE et al. Use of selective serotonin reuptake inhibitors and suicidal ideation: findings from the 2007 National Survey of Mental Health and Wellbeing. Med J Aust. 2010 Jan 4;192(1):53.
- Prevención de la conducta suicida. Washington, DC : OPS, 2016.
- Prevención del Suicidio, un imperativo global. OMS-OPS, 2014.
- Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Orientaciones para su Implementación. Ministerio de Salud de Chile, 2013.
- Recomendaciones para la atención integral de salud de los y las adolescentes, con énfasis en salud sexual y reproductiva. OPS, 2000.
- Ronquillo L, et al. P. Literature-based recommendations for suicide assessment in the emergency department: a review. J Emerg Med. 2012 Nov;43(5):836-42.
- Sheehan DV, et al. The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry. 1998;59 Suppl 20:22-33;quiz 34-57.
- Weber AN et al. Psychiatric Emergencies: Assessing and Managing Suicidal Ideation. Med Clin North Am. 2017 May;101(3):553-571.